

10 - 10- Les Troubles Psychosomatiques - Pr. ADALI

(0:00 - 0:19)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver pour traiter ce cours sur les troubles psychosomatiques. L'approche psychosomatique est une manière de considérer la maladie somatique. On ne peut parler de psychosomatiques qu'en présence de symptômes somatiques et de maladies somatiques réelles.

(0:21 - 0:45)

Les troubles psychosomatiques n'ont pas une définition correcte et claire. Il s'agit au fait d'une maladie comportant des atteintes objectivables d'un organe ou de son fonctionnement. La dimension psychologique serait prépondérante dans la survenue et dans l'évolution de la maladie.

(0:45 - 1:11)

Mais l'organe touché ou la personne était certainement prédisposée biologiquement à présenter cette maladie. Une fois installé, le trouble physique évolue à son propre compte indépendamment des facteurs psychologiques qui ont été à son origine. Les troubles psychosomatiques sont l'expression corporelle, les tensions psychologiques.

(1:14 - 1:35)

Chez les malades psychosomatiques, ce sont les muscles lisses qui sont atteints et les viscères. Contrairement à l'hystérie où c'est la motricité volontaire qui est touchée. Le choix de l'organe n'a aucune signification contrairement à l'hystérie.

(1:38 - 2:12)

Il y a d'abord les maladies physiques influencées par des facteurs psychologiques. Notamment les troubles cardiovasculaires, l'asthée, l'asthme, certaines pathologies dermatologiques, notamment le psoriasis, les maladies de système, les maladies digestives, notamment le Crohn, la RCH, le diabète, l'obésité et autres. Il y a des maladies physiques qui sont à expression psychiatrique, c'est-à-dire les symptômes psychiatriques font partie du tableau de la maladie physique.

(2:13 - 2:55)

Il y a d'abord les dents, les maladies infectieuses, la neurosyphilis, je vous demande de vous référer à votre cours sur les troubles psychiatriques et neurosyphilis, les méningocéphalites, la fièvre typhoïde, le sida. Les maladies neurochirurgicales, notamment les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales, surtout d'origine frontale, réalisent des tableaux de dépression, d'épisodes

maniaques, de troubles du comportement. Certaines maladies endocriniennes, notamment de la thyroïde, comme l'hyperthyroïdie qui réalise des tableaux de troubles anxieux avec de l'irritabilité.

(2:56 - 3:15)

Il réalise aussi un état d'épisode dépressif majeur. L'hyperthyroïdie aussi qui donne un tableau fait de dépression, d'apathie et autres. Les maladies inflammatoires de système comme le lupus, où on trouve des troubles de l'humeur, des troubles du cours de la pensée.

(3:16 - 3:42)

Et la prise de certains médicaments, notamment les corticoïdes, qui peuvent donner un tableau d'accès psychotique aiguë post-toxique. Dans l'approche psychanalytique, on plaide pour un mécanisme inconscient à l'origine des manifestations corporelles. Ce qui ne se décharge pas dans la psyché, s'écoule dans la corporealité.

(3:45 - 4:15)

C'est-à-dire que l'énergie qui est mise en jeu par les traumatismes psychologiques ne peut être suffisamment mentalisée ou digérée par les patients. Et elle emprunterait la voie de la somatisation. Dans l'approche cognitive ou comportementale, les maladies psychosomatiques seraient le résultat d'une réaction inadaptée à une sensation corporelle qui est normale et bénie.

(4:16 - 4:33)

Qui est mal interprétée comme étant due à une maladie physique. Cette interprétation prend en considération les expériences précédentes du patient. C'est un schéma montrant le modèle cognitif ou comportemental.

(4:34 - 5:06)

Ici on a un stimulus externe qui va entraîner une attention sélective à des fonctionnements ou à des parties du corps. Par exemple, une augmentation légère des battements du cœur qui va être vue de façon sélective par le patient. Ce symptôme-là va être interprété en fonction des expériences du patient.

(5:06 - 5:28)

Si ses expériences personnelles ou familiales sont positives, c'est-à-dire qu'il a des expériences familiales de personnes qui ont survécu à des troubles cardiaques. Ou bien il n'a pas d'antécédents familiaux de troubles cardiaques. Ce patient va être réassuré, soulagé.

(5:28 - 5:55)

Par contre, s'il a des antécédents familiaux de personnes qui sont mortes à cause de pathologies

cardiaques, cette personne va interpréter ce symptôme physique qui est bénin de façon catastrophique. Il va appréhender et se soucier. Il va considérer qu'il a une maladie cardiaque grave.

(5:55 - 6:37)

Il tombera dans un cercle vicieux. Il faut savoir aussi que le stress, qu'il soit biologique ou héréditaire, ou une certaine pathologie psychiatrique, entraîne aussi cette interprétation catastrophique de symptômes bénins. Dans l'approche biologique de la psychoneuroimmunologie, dans l'approche biologique de la psychoneuroimmunologie, je vous ai choisi le modèle du sida.

(6:38 - 7:20)

Les études ont montré que certains porteurs sains du HIV déclenchent le sida maladie peu de temps après l'annonce du diagnostic. Cette annonce est considérée comme étant un choc traumatique qui va ébranler tout le système immunitaire et va entraîner le stade sida. La notion d'événements de vie aussi importante, qu'il s'agisse d'événements de vie majeurs, peuvent être traumatisants, engendrant le pronostic vital.

(7:20 - 7:54)

Aux mineurs, représentés par les soucis et les tracasseries de la vie quotidienne, leur cumul peut aussi entraîner un stress important et engendrer des troubles psychosomatiques. Les événements de vie anciens apparaissent tôt dans la vie. Ils aboutissent à une vulnérabilité qui se manifeste en âge adulte par des états dépressifs ou des situations de stress.

(7:55 - 8:19)

Les événements récents peuvent précipiter aussi la survenue d'un trouble psychosomatique. Les modèles de coping sont issus des théories cognitivo-comportementales. Il s'agit de l'ensemble des efforts cognitifs comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources du sujet.

(8:23 - 8:56)

Ainsi, une réponse inadaptée à une situation, par exemple la maladie, est évaluée comme débordant les ressources et pouvant mettre en danger le bien-être de la personne. Les stratégies d'adaptation au stress peuvent être de différentes natures. Résolution de problèmes, notamment la recherche d'informations, l'acceptation de la confrontation, la prise de distance ou la minimisation des menaces, la réévaluation positive, la recherche d'un soutien social et autres.

(8:56 - 9:26)

Les diagnostics différenciés peuvent être d'abord le trouble de somatisation. Il s'agit d'un cortège de plaintes somatiques qui ne peuvent pas être expliquées par un examen physique ou des examens complémentaires de façon adéquate. Les réponses émotionnelles perpétuent ces symptômes.

(9:28 - 9:47)

Ils sont influencés aussi par la détresse psychologique. Ils sont de prévalence entre 0,2 et 2 %, 20 fois plus fréquents chez les femmes. Ils peuvent être comorbides aussi avec la dépression.

(9:51 - 10:19)

Le trouble de conversion, on l'a vu dans le cours de l'hystérie. L'hypochondrie, c'est la crainte ou la croyance d'être atteint d'une maladie sérieuse qui est fondée sur l'interprétation erronée de certaines sensations, symptômes physiques. Ces patients-là restent inaccessibles à la réassurance, même s'il y a, si tout le bilan est normal.

(10:20 - 10:38)

Ils sont convaincus qu'ils sont atteints d'une maladie grave qui n'a pas encore été découverte. L'hypochondrie touche 4 à 6 % de la population générale. Elle peut être aussi comorbide avec la dépression.

(10:42 - 11:02)

Le trouble douloureux est une douleur dans une ou plusieurs localisations anatomiques. Cette douleur est d'une intensité suffisante pour justifier un examen clinique. Les facteurs psychologiques jouent un rôle important dans son déclenchement, dans son intensité, dans son aggravation et dans sa persistance.

(11:05 - 11:23)

La peur d'une dysmorphie corporelle, c'est une préoccupation concernant un défaut imaginaire de l'apparence physique. Même s'il y a un léger défaut physique qui est apparent, les préoccupations sont manifestement démesurées. La conduite à tenir.

(11:24 - 11:35)

D'abord, réaliser une analyse fonctionnelle. L'examen débute par le symptôme somatique. Il faut tenter d'aider le patient à situer le symptôme dans son histoire personnelle.

(11:36 - 11:45)

Rechercher des événements de vie, le support social. Rechercher des facteurs de stress. Apprécier le mode de fonctionnement mental du patient.

(11:46 - 11:59)

Apprécier ses réponses ou ses stratégies de coping. Rechercher d'éventuelles comorbidités psychiatriques. Les mesures générales de traitement.

(12:00 - 12:08)

Il ne faut pas contester la légitimité du trouble. Même pas pour rassurer. Éliminer une cause organique.

(12:08 - 12:25)

Éviter les placebo tels l'injection de sérum salé ou les traitements purement symptomatiques. Rechercher une atténuation du symptôme. Et de son retentissement social plutôt qu'une guérison.

(12:29 - 12:50)

Il faut mettre en oeuvre un raisonnement qui tient compte de l'écoute attentive, des facteurs environnementaux, des données de l'anamnèse, de l'examen clinique et des résultats des examens sains. Il s'agit au fait de prendre en soin le patient et de renoncer à le guérir. Éviter d'employer des mots qui aggravent.

(12:50 - 13:09)

Vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Et éviter de délivrer des médicaments à taux pris. Les mesures générales de traitement reposent aussi sur l'explication au malade de la nécessité d'une évaluation psychiatrique et somatique de façon simultanée.

(13:15 - 13:46)

Certaines mesures spécifiques thérapeutiques peuvent être bénéfiques, notamment la relaxation ou toute thérapie corporelle. Certains traitements pharmacologiques, notamment les antidépresseurs, à durée limitée, dose minimale efficace, font informer le patient. Les psychothérapies comme les TCC, on apprend au patient des stratégies de coping, stratégies de résolution de problèmes.

(13:48 - 14:07)

Les thérapies systémiques, de la psychanalyse et autres. Des conseils importants pour le patient et sa famille s'avèrent nécessaires, surtout par le médecin généraliste qui est le premier médecin qui voit le malade. Et c'est le médecin qui va probablement le suivre.

(14:10 - 14:27)

Il faut expliquer que les symptômes sont réels et non pas une simulation. Il faut demander au patient s'il a une idée sur la cause de ses symptômes. Il faut réassurer de façon appropriée, c'est à dire qu'une douleur abdominale n'est pas synonyme d'un cancer.

(14:28 - 14:50)

Aviser le patient de ne pas se focaliser sur des maladies graves et chercher s'il y a un lien entre le stress émotionnel et l'apparition des symptômes. On conseille aussi au patient la relaxation pour atténuer les symptômes. Insister sur les activités agréables, surtout celles que le patient préférait.

(14:51 - 15:30)

Ne pas attendre la disparition des symptômes pour retourner aux activités. Pour les patients avec des plaintes multiples, il faut programmer des consultations rapprochées pour éviter qu'ils vous viennent en catastrophe ou urgence. Le stress induit souvent des symptômes physiques.

L'attention doit être centrée sur l'amélioration et non pas la découverte d'une étiologie. La disparition des symptômes peut ne pas être possible. Le but de la prise en charge est d'améliorer la qualité de vie du patient malgré la persistance des symptômes.

(15:30 - 15:50)

En conclusion, les troubles psychosomatiques nécessitent une prise en charge multidisciplinaire et un traitement curatif de la maladie somatique. La qualité de la relation médecin-malade est essentielle. Les approches corporelles sont très bénéfiques, notamment la relaxation.

(15:51 - 16:09)

Les prises en charge psychothérapeutiques ou psychiatriques sont basées sur les psychothérapies, les TCC et sur certains traitements médicamenteux, notamment les antidépresseurs. Je vous remercie pour votre attention.